

Fecha Última Actualización: 30-05-2022 13:07:12

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Camilo Andres Olmeño Molina

Rut : 21.029.306-K

N° Archivo : 0223716

N° Epicrisis

308765

Edad : 19a 11m 26d

Fecha Nacto: 31/05/2002

Sexo : Masculino

Dirección : Del Tranque 1498 Los Pensamientos

Comuna : Puente Alto

Teléfono : 9 5865 3326

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 16/04/2022 20:07

Días Estadía: 40

Unidad de Egreso : Utim

Fecha Egreso : 26/05/2022 23:05

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

shock hemorragico

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre: Camilo Andrés Olmeño Molina

Edad: 19 años

RUN: 21.029.306-K

FI HSR: 16/05/22

FI UCI: 16/05/22

FI UTIM 5º: 26/05/22

FI SALA: 27/05/22

ANTECEDENTES:

-Sin antecedentes mórbidos, quirúrgicos ni uso de fármacos conocidos

-Hábitos: no conocidos

HISTORIA:

Ingres a Reanimador sin signos vitales en ingreso, con herida arma blanca en hemitórax izquierdo anterior, trasladado por SAMU refiriendo signos vitales estables a las 19:15 hrs pero PCR en ambulancia, RCP 10 minutos (no especificada duración, ritmo intraparo ni ritmo de salida). A la evaluación en urgencia no describen signos vitales. Se activa protocolo de transfusión masiva. En Reanimador no se describe si presenta nuevo PCR pero sí describen que se realiza toracotomía anterolateral izquierda de emergencia con clampeo aórtico y requerimiento de masaje cardíaco directo.

Ingres a pabellón con SV, describiendo PA 130/60, satO2 100% con FiO2 30%.

ISTAT de ingreso: pH 6.9, pCO2 60, pO2 85, BIC 13, SatO2 87%, Na 141, K 5.2, Glu 326, Hto 47%, Hb 16.

En protocolo quirúrgico se describen abundantes coágulos del pericardio con dos lesiones ventriculares con sangrado activo. Se realiza rafia con punto simple con seda en cara anterolateral y un punto con pledjets en cara inferior. Cierre parcial de pericardio. Se instala pleurostomía izquierda. Cierre de tórax. Denudación venosa femoral derecha para reanimación, posteriormente cierre con corchetes. Completa Tx de 6 U GR, 8 U Crioprecipitado y 6 U Plasma. Tiempo operatorio 2 horas.

Ingres a recuperación bajo sedación con Fentanyl/Midazolam. Describen taquicardia sinusal FC 101x₁, con PAM 80 con bajas dosis de NA que se suspende. En modalidad AC/V FiO2 40 %, sat 95 % VT 6 ml kg PEEP 6.

Es trasladado a UPC con requerimiento de NAD 0.06 ug/kg/min, en SAS 2 con BIC Fentanyl/Propofol, mal perfundido a distal,

Fecha Epicrisis : 30/05/2022 13:07

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 30-05-2022 13:07:12

Página 2 de 3

frio, no se logra inicialmente adecuada medición de saturación dado hipoperfusión. TRC 5 seg. Se conecta a VM.

EVOLUCIÓN DURANTE SU HOSPITALIZACIÓN:

Hemodinámico: Volemización agresiva con cristaloides y hemoderivados, se logra aclaramiento del lactato y destete de DVA. Evoluciona normotenso, con tendencia a la taquicardia sinusal pero sin repercusión sistémica. Se decide no reinicio de DVA en caso de requerirlo.

Respiratorio: Inicialmente con VMI protectora. Inicialmente no se pudo avanzar en weaning dado compromiso de conciencia por lo que se realiza TQT el 02/05/22 y se inicia entrenamiento ventilatorio. Se logra destetar de VMI el 23/05 manteniéndose en filtro hasta el momento del fallecimiento.

Trauma: Toracotomía de urgencia con masaje directo. Se realiza rafia ventricular con instalación de drenajes pleurales. Evolución favorable, se retira pleurostomía el 19/05 (accidental), sin requerimientos de instalación.

Renal: Sin conflicto de función renal ni ELP.

Infeccioso: Inicialmente completó 7 días de Ampicilina Sulbactam por sospecha de neumonía aspirativa, con buena respuesta. Posteriormente cursa febril, con elevación de parámetros inflamatorios. Se aísla en CAET y UC un ACBA con sensibilidad intermedia a AMS por lo que inicialmente se trata con Colistin y posteriormente se rota a Ampicilina sulbactam en dosis altas.

Neurológico: Tras suspensión de sedación paciente no recupera conciencia evolucionando con mioclonías generalizadas.

- TAC cerebro con edema cortical difuso, dudosa lesión isquémica en pedúnculo cerebeloso inferior. Sin hemorragias o lesiones focales.

- EEG: DLGG. Signos de impregnación farmacológica.

- Inicia manejo con FAE, posteriormente se agrega sedación con Midazolam + Propofol para manejo de mioclonías.

- RNM de cerebro compatible con encefalopatía hipóxico isquémica.

Evaluable por Neurología se informa mal pronóstico neurológico a corto plazo, se decide limitación del esfuerzo terapéutico.

DIAGNÓSTICOS ACTUALES:

1.PCR prehospitalario presenciado (reanimado x 10 min)

ii.Herida penetrante en hemitórax izquierdo - penetrante cardíaca - taponamiento pericárdico

iii.Masaje cardíaco abierto xtoracotomía anterolateral en box (16/04/2022)

iv.S/p sutura de heridas en pabellón - 2 heridas ventriculares (16/04/2022)

b.Encefalopatía hipóxico isquémica grave

i.Mioclonías

ii.Pronóstico ominoso

2.Insuficiencia respiratoria en resolución

a.TQT desde 02/05/22

b.ITU/NAVVM por ACBA

Paciente se traslada a cuidados especiales el 27/05/22. Se mantiene manejo sintomático y terapia anticonvulsivante.

Fallece el 29/06/22 a las 09:40 hrs.

Diagnóstico de Egreso

Encefalopatía Hipóxico Isquémica - Pcr Recuperado

Shock Hipovolemico - Herida Penetrante Cardíaca

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

Paciente fallece

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 30/05/2022 13:07

Página 2 de 3

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 30-05-2022 13:07:12

Página 3 de 3

INTERNO

Becado/Residente



Alberto Sarfatis Feige

Médico Tratante (Staff)